

Najpierw inni, *potem Ty*

Pacjent czuje 90% odpowiedzialności. Po rozbiciu na czynniki — zwykle 2–10%. Kolejność wymieniania jest kluczowa.

CZAS: 20 min — protokół sesji Sesje 5–8 terapii CBT-ERP

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1985); Lopatka i Rachman (1995); Abramowitz i wsp. (2019)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz konkretną obsesję typu „jeśli się stanie X, to *moja wina*”. **Kolejność krytyczna:** (1) najpierw wymień 8–12 *innych* czynników wpływających na sytuację; (2) *potem* dopisz siebie; (3) rozdziel **100%** między wszystkie czynniki — udział pacjenta zwykle 2–10% (vs subiektywne 90%); (4) narysuj wykres. Wróć do tego w impulsie sprawdzenia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tort odpowiedzialności (ang. *responsibility pie chart*; Salkovskis, 1985) to **wizualne rozbicie** wyolbrzymionej odpowiedzialności na realne czynniki. Lopatka i Rachman (1995): *eksperymentalne zmniejszenie* poczucia odpowiedzialności u pacjentów z OCD **redukuje kompulsje** w sesji. Nadmierna odpowiedzialność (*inflated responsibility*) jest **centralnym mechanizmem** OCD. Pacjent przypisuje sobie 90% odpowiedzialności za każde możliwe nieszczęście — bez patrzenia na inne czynniki. **Klucz protokołu:** kolejność wymieniania. Gdyby pacjent zaczął od siebie, dałby sobie 90% — reszta czynników nie zmieściłaby się. Zaczynając od *innych*, suma zostawia dla pacjenta tylko 2–10% — co odpowiada **obiektywnej rzeczywistości**.

01 ? Dlaczego kolejność jest kluczowa

ZŁA KOLEJNOŚĆ — OD SIEBIE

„Ile % to moja wina?” — 90%.
„Ile innych czynników?” — *tylko* 10%.

Rezultat: potwierdzenie subiektywnego poczucia.
Ćwiczenie *nie działa*.

DOBRA KOLEJNOŚĆ — NAJPIERW INNI

„Wymień 8–12 czynników bez siebie” — np. instalacja, producent, ubezpieczyciel...
Każdy ma swoje %. Suma się zbiera.

Rezultat: pacjentowi zostaje 2–10%. Realistyczna proporcja.

02 ? Protokół 4-stopniowy

1 Scenariusz. Wybierz konkretną obsesję: „Wyobraź sobie, że dom się pali. Kto/co jest odpowiedzialne?”

2 Lista bez siebie. Wymień 8–12 czynników: wadliwa instalacja, producent kuchenki, firma gazowa, ubezpieczyciel, pogoda, sąsiad, los, starość budynku, system alarmowy, straż pożarna, drobne usterki, materiały budowlane.

3 Proporcje. Rozdziel 100% między czynniki — **zaczynaj od innych**, kończ na sobie. Udział pacjenta zwykle 2–10%.

4 Wykres. Narysuj *wizualnie* proporcje. Typowy obraz: jeden mały kawałek dla pacjenta, reszta dla innych czynników.

03 Twój protokół

MÓJ SCENARIUSZ

— konkretna obsesja typu „moja wina, jeśli...”

CZYNNIK WPŁYWU — NAJPIERW BEZ SIEBIE	UDZIAŁ (%)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ja — DOPIERO NA KOŃCU

Suma = 100%:

04 Zastosowanie w codzienności

W IMPULSIE SPRAWDZENIA

„Czy 90% czy 5%?” — szybkie pytanie. **Wracaj do swojej liczby** z analizy.

KARTA W PORTFELU

Zapisz wynik analizy na karcie i noś w portfelu. **Wyciąga się ją w trudnych momentach.**

POWTARZANIE DLA RÓŻNYCH OBSESJI

Jeśli masz kilka obsesji „moja wina” — zrób **oddzielny tort** dla każdej. Każda ma inne czynniki.

TEST BEHAWIORALNY PO TORCIE

Po analizie — **zmniejsz sprawdzanie**. Obserwuj: czy katastrofy z *innych źródeł* się rozkładają tak, jak pokazał tort?

Klucz: Lopatka i Rachman (1995): eksperymentalna manipulacja poczuciem odpowiedzialności **natychmiastowo** wpływa na zachowania kompulsyjne. Pacjenci, którym (eksperymentalnie) zwiększono odpowiedzialność za hipotetyczne zadanie, *nasilali* sprawdzanie; tym, którym zmniejszono — *redukowali*. To dowód, że **odpowiedzialność jest dźwignią**, nie tylko korelatem. Klucz pracy: pacjent *doświadcza* redukcji odpowiedzialności podczas analizy. Łącz z **techniką podwójnego standardu** — co byś powiedział/-a osobie z 5% udziału w wypadku? Ta sama logika do siebie. Karta z wynikiem analizy noszona przy sobie wzmacnia efekt w trudnych momentach.